

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

TEST DE ADICCIÓN A INTERNET (IAT)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación de Uso Problemático y Compulsivo de la Red y Pantallas

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Test de Adicción a Internet (IAT).
Nombre Original (Inglés)	<i>Internet Addiction Test (IAT)</i>
Autora Original	Dra. Kimberly S. Young (1998), Center for Internet Addiction Recovery, EE. UU.
Adaptaciones Españolas	Fernández-Villa et al. (2015, validación en jóvenes españoles); Puerta-Cortés y Carbonell (2013); Gómez et al. (2017).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Evaluación de adicciones comportamentales y tecnologías.
Tipo de Instrumento	Autoinforme de 20 reactivos politómicos puntuados en escala Likert de 5 anclajes (1 a 5).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (>= 13 años). Ámbitos educativos, clínicos de salud mental y medicina preventiva.
Tiempo de Administración	5 a 8 minutos.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para evaluación clínica, psicoeducativa y de investigación no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO DE CIBERADICCIÓN

El IAT fue desarrollado por Kimberly Young (1998) adaptando los criterios de dependencia de sustancias y juego patológico del DSM-IV al contexto de las tecnologías de la información. El instrumento define la adicción a Internet como un patrón desadaptativo de conexión digital caracterizado por la pérdida progresiva del control del tiempo, dependencia psicológica y grave deterioro sociolaboral o académico.

El marco teórico distingue cuatro mecanismos neurobiológicos y cognitivos interconectados: la **salencia cognitiva** (pensar continuamente en volver a conectarse cuando se está fuera de línea), la **tolerancia conductual** (necesidad de permanecer cada vez más horas frente a la pantalla para alcanzar satisfacción), el **alivio de afecto negativo** (uso de la red como vía de escape o automedicación de la ansiedad, soledad o disforia) y el **conflicto psicosocial** (discusiones familiares, abandono del sueño y desinterés por actividades reales).

3. DIMENSIONES FACTORIALES EVALUADAS EN EL IAT (YOUNG, 1998)

Dimensión Factorial	Ítems	Rango Dir.	Contenido y Significación Psicológica
1. Salencia y Pérdida Control	1, 2, 5, 7, 13, 17	6 a 30	Quedarse más tiempo del planeado, quejas de otros, anticipar la próxima conexión y fracaso en reducir el uso.
2. Negligencia de Deberes	6, 8, 9, 10, 11, 16	6 a 30	Baja de rendimiento académico/laboral, quejas de amigos y parejas, y secretismo sobre las horas de uso.
3. Desregulación y Escape	3, 12, 14, 15, 18	5 a 25	Preferir la emoción de internet a la compañía íntima real, evitación de problemas vitales e irritabilidad.
4. Privación de Sueño	4, 19, 20	3 a 15	Trasnochar habitualmente conectado, cansancio diurno y estar deprimido o nervioso desconectado.
PUNTUACIÓN TOTAL IAT	1 al 20	20 a 100	Índice multidimensional integral de gravedad de la adicción a Internet.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA

Consistencia Interna	Excelente fiabilidad: alfa de Cronbach de 0.89 a 0.93 en adolescentes y jóvenes universitarios españoles (Fernández-Villa et al., 2015; Gómez et al., 2017).
Validez Concurrente	Correlación positiva y robusta con escalas de nomofobia, adicción a redes sociales ($r = 0.74$), impulsividad (UPPS-P $r = 0.52$) y síntomas depresivos (BDI-II $r = 0.48$).
Estabilidad Temporal	Fiabilidad test-retest $r = 0.82$ a las cuatro semanas en muestras educativas.
Validez Discriminante	Diferencia de forma estadísticamente concluyente entre usuarios normativos de la red y personas con adicción comportamental diagnosticada.
Invarianza Factorial	Invarianza métrica demostrada en función del sexo, si bien los varones muestran puntuaciones más altas en videojuegos online y las mujeres en redes sociales.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN DE ÍTEMS

Cada afirmación se puntúa en una escala de frecuencia de 5 puntos:

- **1** = Raras veces | **2** = Ocasionalmente | **3** = Frecuentemente | **4** = A menudo | **5** = Siempre.
- **Puntuación Total IAT:** Suma directa de los 20 reactivos (Rango: **20 a 100 puntos**).

Puntuación Total = Suma de ítems 1 al 20 (Rango de 20 a 100 puntos)

6. BAREMOS Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA (YOUNG, 1998; FERNÁNDEZ-VILLA ET AL., 2015)

Estrato	Puntuación	Patrón de Conexión	Conducta Asistencial Recomendada
Normal	20 a 39	Usuario digital controlado / Adaptativo	Navegación dentro de parámetros saludables de ocio y trabajo. Pautas de higiene digital general.
Moderado	40 a 69	Uso problemático frecuente / En riesgo	Problemas periódicos de control del tiempo y discusiones familiares. Psicoeducación y pautas de límites.
Severo	70 a 100	Adicción Grave a Internet (Corte)	Colapso de horarios, absentismo, aislamiento físico severo. Intervención psicoterapéutica especializada.

VALOR PREDICTIVO DEL ÍTEM 4 (PRIVACIÓN DE SUEÑO): Puntuar 4 o 5 en el reactivo 4 ("¿Con qué frecuencia pierde horas de sueño por quedarse conectado hasta tarde?") es el indicador más robusto de descompensación de ritmos circadianos, fracaso académico en adolescentes y comorbilidad ansioso-depresiva.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y DIETA DIGITAL

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS (USO CONTROLADO VERSUS ABSTINENCIA):

- **Meta de Intervención:** A diferencia de las sustancias químicas, en adicción a pantallas el objetivo no es la abstinencia total (imposible en el mundo moderno), sino la **reeducación y uso funcional controlado**.
- **Control de Estímulos:** Retirar el smartphone del dormitorio durante la noche; uso de aplicaciones de bloqueo temporal; desconexión programada de la red Wi-Fi familiar a partir de las 22:30 horas.
- **Reactivación de Refuerzos Naturales:** Terapia conductual dirigida a reconectar con aficiones físicas, práctica deportiva al aire libre y encuentros interpersonales presenciales.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: ADICCIÓN A REDES SOCIALES EN ADOLESCENTE

Paciente: Chica de 15 años, estudiante de 4.º de ESO, traída por su madre tras detectarse una caída brusca en sus calificaciones, somnolencia diurna crónica y episodios de agresividad verbal cuando se le retiraba el teléfono móvil por las noches.

Resultados IAT:

- **Puntuación Total: 79/100 (Adicción Severa — Rango Grave).**
 - **Desglose dimensional:** Salencia y Pérdida de Control = 26/30; Privación de Sueño = 15/15 (se quedaba conectada a redes hasta las 04:00 AM); Negligencia de Deberes = 23/30; Desregulación Emocional = 15/25 (ansiedad intensa y taquicardia al quedarse sin batería o cobertura).
- Conducta Asistencial:** Se diagnostica Adicción Comportamental a Redes Sociales e Insomnio por Desfase de Fase Circadiana. Se acuerda un contrato familiar de límites digitales: teléfono fuera de la habitación a partir de las 22:00 h, despertador analógico tradicional y sustitución de pantallas por lectura antes de dormir. En psicoterapia se trabaja el miedo a perderse algo (*FOMO*) y la autoestima desligada de la validación por “likes”. A los 2 meses, el IAT descendió a 38/100 (rango controlado), restableciendo el descanso nocturno y el rendimiento escolar.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA

ALERTA: SÍNTOMAS DISFÓRICOS Y ANSIEDAD

La retirada brusca de pantallas sin acompañamiento puede desencadenar crisis agudas de angustia, agitación psicomotora y conductas agresivas hacia progenitores; pactar límites graduados.

RIESGOS DE VULNERABILIDAD DIGITAL

En adolescentes con puntuaciones extremas deben explorarse activamente situaciones de ciberacoso escolar (*cyberbullying*), contacto con desconocidos (*grooming*) o juego de azar encubierto.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Young, K. S. (1998). *Caught in the net: How to recognize the signs of internet addiction and a winning strategy for recovery*. John Wiley & Sons.
2. Fernández-Villa, T., et al. (2015). Validación y propiedades psicométricas del Internet Addiction Test en jóvenes españoles. *Adicciones*, 27(4), 268–277.
3. Puerta-Cortés, D. X., & Carbonell, X. (2013). Uso problemático de Internet en una muestra de estudiantes universitarios colombianos. *Universitas Psychologica*, 12(4), 1189–1198.
4. Widyanto, L., & McMurran, M. (2004). The psychometric properties of the internet addiction test. *CyberPsychology & Behavior*, 7(4), 443–450.